Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Av. Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53)3026-8500 - Email: frpelotas5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5019116-44.2021.8.21.0022/RS

AUTOR: JOAO VITOR MULLER GARCIA DA SILVEIRA

RÉU: UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

JOÃO VITOR MÜLLER GARCIA DA SILVEIRA (menor impúbere representado pela genitora Débora Müller Garcia) ajuizou a presente *ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais* em face de **UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA**. Disse ser criança portadora de Hidrocefalia (CID G91.8) e, nesta condição, necessitar de tratamento fármaco com Canabidiol, 200mg/ml, em dose diária de até 0,5ml (1 frasco/mês), autorizado pela ANVISA e comercializado em drogarias nacionais. Assegurou que a ausência de tratamento aumentaria o risco de morte súbita associado à epilepsia (SUDEP). Entendeu pela obrigação de cobertura de todas as doenças relacionadas no rol da CID-10 da OMS, inclusive das não expressamente cobertas pelo rol da ANS. Rogou pela procedência da pretensão, com a liberação pelo plano de saúde do fármaco Canabidiol, 200mg/ml, dose diária de até 0,5ml (1 frasco/mês), além de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. Requereu a concessão de medida liminar *inaudita altera pars* e a gratuidade judiciária. Juntou documentos.

Em novas manifestações, a parte autora acostou documentação complementar e noticiou o aumento da dose prescrita pelo médico responsável por seu tratamento para 0,5ml/12h.

Intimado, o Ministério Público informou intervir no feito e opinou pelo indeferimento da tutela antecipada.

Concedida a gratuidade judiciária à parte autora e indeferido o pedido antecipatório.

Citada, a parte ré apresentou contestação. Defendeu a ausência de previsão contratual de cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, o qual, ademais, tampouco constaria no rol da ANS. Assim, entendeu pela ausência de irregularidade em seu proceder. Postulou a improcedência dos pedidos autorais, juntando documentos.

Sobreveio réplica.

Em decisão saneadora, invertida a distribuição do ônus da prova e, instadas as partes quanto à dilação probatória, nada requereram.

Intimado, o Ministério Público apresentou parecer final, opinando pela improcedência da demanda.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relatório. DECIDO.

A demanda tem simples resolução.

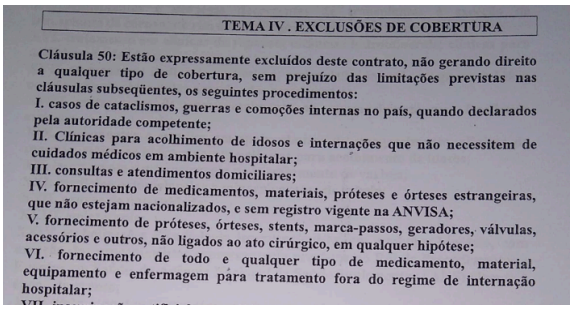
Não obstante a incontrovérsia acerca da condição de saúde da parte autora (evento 1, LAUDO10 e evento 1, LAUDO11) e de sua titularidade de plano de saúde junto à parte ré (evento 7, CONTR4), bem assim da prescrição do medicamento descrito em inicial (evento 9, RECEIT2), os fatos mencionados não se mostram suficientes para ensejar a procedência da demanda.

Em decisão recente proferida no EREsp 1.886.929, o STJ entendeu pela taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), conforme proclamação final de julgamento abaixo colacionada:

> ***1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo****;*
>
> *2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;*
>
> *3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;*
>
> *4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.*

Assim sendo, é evidente a não obrigatoriedade de cobertura para procedimentos e eventos em saúde suplementar que não expressamente dispostos no rol da Resolução Normativa nº 465/2021[1], como ocorre no caso em comento.

Não bastasse isso, no caso telado a pretensão autoral versa acerca de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído do plano contratado (cláusula 50, inc. VI), o que encontra respaldo legal nas redações dos arts. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998[2] e 19, § 1º, inc. VI, da RN nº 338/2013 da ANS[3].



TEMA IV . EXCLUSÕES DE COBERTURA

Cláusula 50: Estão expressamente excluídos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuízo das limitações previstas nas cláusulas subseqüentes, os seguintes procedimentos:
I. casos de cataclismos, guerras e comoções internas no país, quando declarados pela autoridade competente;
II. Clínicas para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar;
III. consultas e atendimentos domiciliares;
IV. fornecimento de medicamentos, materiais, próteses e órteses estrangeiras, que não estejam nacionalizados, e sem registro vigente na ANVISA;
V. fornecimento de próteses, órteses, stents, marca-passos, geradores, válvulas, acessórios e outros, não ligados ao ato cirúrgico, em qualquer hipótese;
VI. fornecimento de todo e qualquer tipo de medicamento, material, equipamento e enfermagem para tratamento fora do regime de internação hospitalar;

É, ademais, o que entende o STJ:

> *RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.* ***3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).*** *4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)*

Pelo exposto, não há embasamento legal que justifique a condenação da parte ré à obrigação de fazer requerida pela parte autora.

Consequentemente, não há ato ilícito praticado pela parte demandada, porquanto pautou-se segundo regramento legal vigente e consoante entendimento consolidado pela jurisprudência, não havendo falar-se assim em dever de indenizar, pelo que também de ser desacolhido o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Posto isso, forte no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em prol do procurador da parte ré, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado (IGPM) da causa (R$ 50.000,00), conforme § 2º do art. 85 do CPC. **Suspensa a exigibilidade, contudo, em razão do benefício da gratuidade judiciária deferido à parte autora.**

Intimadas as partes.

Interposto apelo e/ou recurso adesivo, independentemente de comando judicial, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Apresentadas as contrarrazões ou certificada a sua não apresentação, remetam-se, de imediato, os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com as homenagens de estilo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC, haja vista que não cabe ao juízo de 1º grau a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA MULLER, Juíza de Direito**, em 15/7/2022, às 0:22:2, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10022064748v21** e o código CRC **29bbcb20**.

---

1. https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw== ↩
2. Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; ↩
3. Art. 19. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998. § 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais previstas no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos no inciso XII do art. 20 e inciso X do art. 21 desta RN e, ressalvado o disposto no artigo 13 desta Resolução Normativa. ↩